MANUAL PRÁTICO — EXOCAD DENTALCAD 3.2

Coroas múltiplas unidas em dentes naturais • 6 a 10 elementos • fluxo para restaurações impressas em resina

Caso-base: 13–23 (6 elementos). Extensões contempladas: 14–24 (8 elementos) e 15–25 (10 elementos).

Como usar este manual: siga a sequência do DentalDB ao STL. Os nomes exatos de botões, materiais e opções podem variar conforme módulos, configuração e bibliotecas instaladas no Exocad 3.2. Quando uma opção da sua tela diferir, confirme antes de avançar.

1. Antes de começar: escolha correta do tipo de restauração

Opção	O que significa	Quando usar
Coroa anatômica / Full contour	Restauração com anatomia externa final completa.	É o ponto de partida usual para coroas monolíticas definitivas, inclusive no fluxo de impressão quando material e indicação permitem.
Coroa reduzida / Reduced crown	Anatomia é reduzida para criar espaço para recobrimento/estratificação.	Quando haverá camada externa/veneering; não significa apenas uma coroa 'mais fina'.
Coifa / Coping	Infraestrutura sem anatomia externa final completa.	Estruturas que receberão recobrimento posterior.
Pôntico	Elemento sem preparo dentário correspondente.	Pontes com espaço edêntulo. Não usar para um dente preparado que receberá coroa.
Provisório	Restauração temporária.	Fluxo provisório quando a indicação/material forem apropriados.

2. DentalDB — criar e configurar o caso

Objetivo: cadastrar todos os pilares no mesmo trabalho.
Passo a passo: crie/abra o paciente → novo trabalho → selecione 13, 12, 11, 21, 22 e 23 (ou amplie para 14–24 / 15–25) → atribua a indicação restauradora adequada a cada preparo → escolha material/fluxo compatível com sua resina e instalação.
Confira: nenhum pilar ficou de fora; não foi marcado pôntico onde existe preparo; todos os elementos pertencem ao mesmo caso.
Erro a evitar: assumir que 'coroa reduzida' é a escolha para diminuir espessura de uma coroa monolítica.

3. Importar escaneamentos

Importe a arcada de trabalho, antagonista e registro de mordida quando disponíveis. Confira orientação, integridade das margens, áreas proximais e ausência de falhas importantes.
Em trabalhos longos: uma distorção de escaneamento ou registro pode repercutir ao longo de toda a peça. Se houver dúvida clínica sobre a fidelidade do escaneamento, resolva antes do desenho.

4. Detectar e revisar as margens

Marque a linha de término de **cada preparo individualmente**. Percorra 360° e corrija manualmente onde a detecção automática não estiver precisa.
Confira: margem contínua, sem saltos para gengiva ou parede axial, especialmente em áreas interproximais.

5. Eixo de inserção — ponto crítico em 6–10 elementos

Avalie os preparos como conjunto. Uma estrutura rigidamente unida precisa conseguir assentar sobre todos os pilares sem interferências incompatíveis.
Quanto maior a extensão, maior a atenção: 8–10 pilares aumentam a chance de divergências entre preparos. O

software ajuda a visualizar retenções/interferências, mas não corrige uma incompatibilidade clínica de inserção apenas 'forçando' o desenho.
Confira antes de avançar: direção de assentamento, áreas retentivas, espaço interno e necessidade clínica de segmentação.

6. Espaço interno e parâmetros da restauração

Use os parâmetros adequados ao material e ao protocolo validado da sua resina. Ajustes como espaço de cimento, início do espaço, espessura mínima e compensações não devem ser copiados de um valor genérico sem considerar fabricante, impressora, pós-cura e validação do fluxo.
Regra prática: não reduza espessura ou aumente folga apenas para fazer uma peça longa assentar.

7. Gerar anatomia

Gere as coroas anatômicas e ajuste proporção, comprimento, linha média, corredores bucais, contatos proximais e relação com antagonistas. Para anteriores, revise também bordas incisais, guia anterior e envelope funcional.
Em 8–10 elementos: faça primeiro uma leitura global do sorriso/arco e depois refinamentos dente a dente.

8. Unir / esplintar os elementos

O objetivo é transformar os elementos planejados em uma restauração conectada conforme as ferramentas disponíveis na sua configuração do DentalCAD. A nomenclatura e o momento exato da função de união/conector podem variar por indicação e instalação.
Confira visualmente: continuidade entre os elementos, ausência de regiões extremamente finas, perfil cervical higienizável e ausência de degraus ou interpenetrações indesejadas.
Importante: para uma peça longa impressa, a geometria da união precisa respeitar a indicação e as exigências mecânicas do fabricante da resina; não use dimensões universais inventadas.

9. Contatos, oclusão e espessura

Ative as ferramentas de análise do DentalCAD e revise contatos proximais e oclusais, espessuras mínimas e distância ao antagonista. Faça a avaliação em movimentos funcionais quando o seu fluxo e registros permitirem.
Procure: contatos excessivos, áreas muito finas, conectores frágeis, superfícies internas alteradas e zonas que possam impedir assentamento.

10. Revisão específica para 6, 8 e 10 elementos

6 elementos (13–23): atenção ao eixo comum e guias anteriores.
8 elementos (14–24): aumenta a extensão e a influência de pré-molares; reavalie inserção e oclusão posterior.
10 elementos (15–25): trate como caso de alta exigência de assentamento e estabilidade. Antes de optar por uma peça única, avalie clinicamente se a extensão, paralelismo dos pilares, material e indicação do fabricante justificam uma estrutura monobloco ou se o caso deve ser segmentado.

11. Finalizar e exportar STL

Antes da exportação, faça uma última inspeção interna e externa. Confirme margens, anatomia, união, espessuras, contatos e ausência de artefatos. Finalize o caso e exporte a geometria no formato usado pelo seu fluxo de impressão.
Depois do Exocad: orientação, suportes, parâmetros de impressão, lavagem e pós-cura devem seguir o protocolo validado para a combinação específica de resina + impressora + equipamento de pós-cura.

Checklist rápido antes de imprimir

■ Todos os dentes/pilares corretos estão no mesmo caso.

■ Indicação restauradora correta em cada elemento.

■ Margens revisadas 360°.

■ Eixo de inserção/assentamento verificado para o conjunto.

■ Espaço interno e espessura conforme protocolo validado do material.

■ Anatomia e estética revisadas.

■ Uniões/conectores revisados, sem áreas excessivamente finas.

■ Contatos proximais e oclusais revisados.

■ Superfície interna não foi deformada durante ajustes.

■ STL final inspecionado antes de enviar ao slicer.

■ Parâmetros de impressão e pós-cura conferidos no protocolo do fabricante.

Nota clínica importante

Este manual é um guia operacional de CAD e não substitui o planejamento clínico, as instruções de uso do material nem a validação do fluxo de fabricação. Em restaurações longas unidas, a decisão entre monobloco e segmentação deve considerar preparos, assentamento, biomecânica, oclusão e a indicação específica da resina.

Para continuar junto no Exocad

Ao executar o caso, se um botão ou nome de opção estiver diferente, envie uma foto/print da tela. O tutorial pode então ser ajustado à sua instalação do Exocad 3.2, etapa por etapa.